Носовое кровотечение

Клинические рекомендации от 08.12.2025 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/977_1. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

R04.0 Носовое кровотечение

Главное

- При кровотечении из передних отделов носа сначала плотно прижимают крылья носа к перегородке на 5 минут и дольше.
- Если кровотечение не угрожает жизни, сначала его останавливают местно — прижатием, сосудосуживающим средством, коагуляцией или тампонадой, — и только потом корректируют свёртываемость или отменяют антикоагулянты.
- Если кровотечение продолжается, а источник не виден, ставят переднюю тампонаду.
- Всем пациентам измеряют артериальное давление: это помогает выявить гипертензию и оценить кровопотерю.
- Госпитализируют, если первичные меры не помогли, кровопотеря большая или кровотечение интенсивное, есть признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология или высокий риск рецидива, а также всегда при переливании крови, задней тампонаде, перевязке сосудов и эмболизации.

Клиника и классификация

Определение

Носовое кровотечение — кровотечение из повреждённых сосудов полости носа, околоносовых пазух или носоглотки, а также из сосудов полости черепа при повреждении верхней стенки полости носа.

Причины

Кровотечения бывают посттравматическими, в том числе после операций, и спонтанными. Спонтанное кровотечение — симптом местной или общей болезни.

Сосуды слизистой носа страдают при её атрофии, специфическом воспалении (туберкулёз, сифилис), опухолях носа и пазух, сосудистых мальформациях и гранулематозе с полиангиитом.

У детей кровотечение чаще всего вызвано повреждением слизистой (инородное тело, травма, в том числе ятрогенная), острыми инфекциями верхних дыхательных путей и опухолями.

У детей до двух лет носовое кровотечение бывает очень редко, примерно у одного из 10 000. Если оно случилось в этом возрасте, нужно исключить болезни крови и врождённую патологию, например гемангиому полости носа и носоглотки.

Классификация

По механизму кровотечение бывает вызвано изменениями сосудов носа, нарушением свёртывания крови или сочетанием причин. По источнику — из передних или задних отделов полости носа, из околоносовых пазух, носоглотки или внутричерепных сосудов.

Клиническая картина

При переднем кровотечении кровь в основном течёт наружу, при заднем — стекает в носоглотку.

Пациенты жалуются на кровянистые выделения из носа, часто на стекание крови по задней стенке глотки и недомогание. Если кровь заглатывалась, бывают дискомфорт в животе, тошнота и чёрный стул.

Общие симптомы и объём кровопотери

Шок	Признаки	Кровопотеря
Не выражен	Признаков нет	до 10% объёма крови (до 500 мл)
Лёгкий	Пульс до 100, систолическое давление выше 100 мм рт. ст., холодные конечности, нормальный диурез	15–20% (750–1250 мл)
Средний	Пульс до 120, систолическое давление 90–100 мм рт. ст., сниженное пульсовое давление, беспокойство, потливость, бледность, диурез меньше 50 мл в час	25–35% (1250–1750 мл)
Тяжёлый	Пульс больше 120, систолическое давление ниже 60 мм рт. ст. или не определяется, ступор, резкая бледность, холодные конечности, сухие язык и кожа, анурия	больше 35% (больше 1750 мл)

Анамнез

Уточняют, когда началось кровотечение, сколько длится и как часто повторяется, с какой стороны были прошлые кровотечения, были ли из-за них госпитализации и переливания крови. Расспрашивают о приёме антиагрегантов, антикоагулянтов и других препаратов, о гипертензии, коагулопатиях, анемии, кровотечениях у родственников, травмах и операциях на носу и пазухах.

Носовое кровотечение может быть первым признаком коагулопатии, наследственной телеангиэктазии, опухоли носа или носоглотки, болезни печени или почек, особенно если оно повторяется. Синяки и петехии без причины и кровотечения из внутренних органов в анамнезе говорят в пользу системного нарушения свёртывания.

Кровотечение на фоне антикоагулянтов (варфарин, гепарин, дабигатран, апиксабан и другие) или антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел) может потребовать отмены или снижения дозы. У таких пациентов кровотечения чаще повторяются и чаще бывают больше 250 мл, требуя переливания крови. Риск повышают также многие спреи для носа, в том числе сосудосуживающие и гормональные, и некоторые наркотические вещества.

Диагностика

Диагноз ставят, когда кровянистые выделения из носа подтверждены при риноскопии и фарингоскопии.

Осмотр

Каждого пациента осматривает оториноларинголог: оценивает состояние, ищет источник кровотечения и выбирает тактику.

Если госпитализация нужна, выбирают стационар с дежурным оториноларингологом. Если во время кровотечения ЛОР-врач пациента не осмотрел, в том числе потому, что кровотечение остановилось само, пациента направляют к нему планово.

Оценивают пульс, сознание, кожу и слизистые, чтобы не пропустить гиповолемию. Обморок, тахикардия, тахипноэ и бледность говорят о гемодинамических нарушениях из-за кровопотери. Кровоизлияния на коже и слизистых без травмы могут указывать на системное нарушение свёртывания.

При повторных кровотечениях из обеих половин носа или если они бывают у родственников, ищут телеангиэктазии на слизистой носа и рта, чтобы не пропустить наследственную геморрагическую телеангиэктазию (болезнь Рандю — Ослера — Вебера).

Всем пациентам измеряют артериальное давление, чтобы выявить гипертензию и оценить гиповолемию: гипотония может говорить о значительной кровопотере.

Если источник не виден при передней риноскопии, проводят эндоскопию полости носа и носоглотки.

Повторяющееся кровотечение с одной стороны может быть первым признаком опухоли, которую не видно при передней риноскопии, а у детей — инородного тела.

Анализы

Общий анализ крови назначают, чтобы оценить постгеморрагическую анемию и тромбоциты; для оценки кровопотери определяют гемоглобин и гематокрит.

Степень кровопотери у взрослого

Степень	Объём кровопотери	Гемоглобин, г/л	Гематокрит, %
I	до 500 мл	больше 120	больше 40
II	500–1000 мл	100–120	30–40
III	1000–1500 мл	80–100	20–30
IV	больше 1500 мл	меньше 80	меньше 20

При повторяющихся кровотечениях и при кровотечении, требующем госпитализации, исследуют гемостаз: МНО, фибриноген, АЧТВ и протромбиновое время. МНО особенно важно у пациентов на варфарине: значение выше 4,5 прогностически неблагоприятно.

При приёме прямых пероральных антикоагулянтов (дабигатран, ривароксабан и др.) эти показатели могут не отражать степень гипокоагуляции.

Консультации

Если есть гипертензия, анемия, коагулопатия или другие сопутствующие болезни, влияющие на кровотечение, пациента консультирует терапевт или педиатр.

При повторяющихся кровотечениях с признаками тромбоцитопатии или коагулопатии в анализах пациента консультирует гематолог.

Лечение

Цель — остановить кровотечение, устранить факторы риска и скорректировать последствия кровопотери, включая гиповолемию и анемию.

Если кровотечение не угрожает жизни, сначала его останавливают местно: прижатием крыльев носа, сосудосуживающим средством, коагуляцией или тампонадой. Только после этого корректируют свёртываемость или отменяют антикоагулянты и антиагреганты, потому что системная коррекция опасна, прежде всего тромбоэмболиями.

Остановка кровотечения

При кровотечении из передних отделов носа сначала плотно прижимают крылья носа к перегородке на 5 минут и дольше, обычно на 5–15 минут. Перед этим пациент сморкается, чтобы удалить сгустки; сидит или стоит, слегка наклонив голову вперёд. Это может сделать и сам пациент. Если кровь продолжает стекать, источник, скорее всего, находится глубже, и нужны другие методы.

Если кровотечение продолжается, а источник найден, взрослым на него накладывают турунду с сосудосуживающим средством, а взрослым и детям можно приложить гемостатик.

Однократно применяют #ксилометазолин или #эпинефрин на турунде; #оксиметазолин в спрее — по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 3 раза в день 3–5 дней (знак # означает применение вне инструкции). Сосудосуживающие препараты осторожно применяют при гипертензии, ИБС и ишемии мозга.

На турунде можно однократно приложить к источнику #транексамовую кислоту (взрослым: 5 мл на кусочек ваты или марли на 10–30 минут) или этамзилат (взрослым и детям).

Если кровотечение продолжается, а источник найти не удаётся, ставят переднюю тампонаду.

Рассасывающиеся материалы, например коллагеновая гемостатическая губка, не нужно удалять, и это их преимущество: при удалении тампона кровотечение может возобновиться. Поэтому при высоком риске повторного кровотечения, например при наследственной телеангиэктазии или болезнях крови, по возможности используют их. У детей источник обычно спереди, поэтому, если ребёнок позволяет, лучше обойтись без тампона; если он не готов к манипуляциям, предпочтительна передняя тампонада.

Если кровотечение из задних отделов не останавливается передней тампонадой, ставят переднюю и заднюю тампонаду с тампоном в области хоан и носоглотки.

Пациента с задним тампоном наблюдают и лечат в стационаре. Нитка или фиксатор не должны сильно давить на крыло носа, иначе образуется пролежень. Некоторые авторы назначают при задней тампонаде системные антибиотики.

Если кровотечение продолжается и источник найден, кровоточащий сосуд коагулируют.

Коагулировать можно химически (нитратом серебра), электрокоагулятором, лазером или радиоволной. Если перед этим приложить сосудосуживающее средство, коагуляция эффективнее.

Если коагуляция и тампонада не помогают, рассматривают эмболизацию сосудов или перевязку артерии.

В редких случаях перевязывают наружную сонную артерию на стороне кровотечения. Эмболизация эффективна до 87% случаев, но осложняется чаще, чем перевязка; её можно делать под седацией и при стоящих тампонах.

При повторяющихся кровотечениях из зоны Киссельбаха отслаивают слизистую перегородки носа.

Операцию не делают при субатрофии слизистой и выраженном искривлении перегородки.

Лекарства

При повышенном давлении назначают антигипертензивные препараты: так уменьшаются кровопотеря и риск рецидива.

Если первичные меры недостаточны, назначают гемостатики: транексамовую кислоту (внутривенно с 1 года, в таблетках с 3 лет), аминокапроновую кислоту, аминометилбензойную кислоту, этамзилат — в дозах по инструкции. При продолжающемся кровотечении лучше вводить внутривенно, таблетки подходят для профилактики рецидивов.

Этамзилат системно оправдан только при диапедезном кровотечении из мелких сосудов слизистой.

При травматическом кровотечении или риске тяжёлого кровотечения пациентам старше года как можно раньше, лучше в первые 3 часа после травмы, вводят транексамовую кислоту внутривенно.

Пациентов с коагулопатиями и переливание крови по возможности ведут вместе с гематологом, терапевтом или педиатром.

Детям с геморрагическим синдромом при дефиците витамина K вводят менадиона натрия бисульфит: новорождённым — до 4 мг в сутки, от месяца до года — 2–5 мг в сутки. Можно вводить и профилактически, не дожидаясь подтверждения дефицита.

После кровотечения или его остановки назначают увлажняющие и заживляющие средства для слизистой носа.

Они уменьшают сухость и корки, чтобы пациент не чистил нос сам; показаны и при субатрофическом рините.

Профилактика и госпитализация

Пациентам объясняют факторы риска повторного кровотечения, как останавливать его самому и когда обращаться к врачу.

Объясняют, что нельзя ковырять в носу, особенно детям, родителям и пожилым; пожилым — что риск связан с лекарствами и подъёмом давления. Слизистую сушат кислородные канюли и аппараты для дыхания под давлением. Пациентам на варфарине обязателен контроль МНО. Если кровотечения повторяются на фоне спреев для носа, дозу уменьшают и учат правильно ими пользоваться.

Если кровотечение связано с повышением давления, пациента консультирует терапевт, педиатр или кардиолог, чтобы подобрать антигипертензивную терапию.

Госпитализация

Нужна ли госпитализация после передней тампонады, решают по длительности кровотечения, объёму кровопотери, признакам гиповолемии, сопутствующим болезням, типу тампона и доступности амбулаторной помощи. При активном кровотечении или нестабильной гемодинамике пациента обследуют и лечат в приёмном или ЛОР-отделении.

При кровотечении на фоне гипертонической болезни ЛОР-врач останавливает кровотечение в приёмном отделении, затем пациента госпитализируют в терапевтический стационар, чтобы нормализовать давление.

При небольшом или уже остановившемся кровотечении пациента можно обследовать амбулаторно.

Госпитализируют, если первичные меры не помогли, кровопотеря значительная или кровотечение интенсивное, есть признаки гиповолемии, тяжёлая сопутствующая патология или высокий риск рецидива. Всегда госпитализируют при переливании крови, задней тампонаде, перевязке сосудов и эмболизации, а также после передней тампонады нерассасывающимся материалом, если удалить тампоны амбулаторно нельзя.

Значительной считается кровопотеря больше 10% объёма крови (около 500 мл у взрослого), интенсивным — кровотечение больше 1 мл/кг в минуту. Риск тяжёлого кровотечения повышают госпитализации из-за кровотечений в анамнезе, особенно с переливанием крови, и больше трёх эпизодов за последние 3 месяца.

Выписывают, когда кровотечение стойко остановлено, признаков гиповолемии нет, гемодинамика нормальная, а сопутствующие болезни компенсированы.

Исход во многом определяют скорость и объём кровопотери: массивная кровопотеря больше 40% объёма крови может быть несовместима с жизнью.

Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Носовое кровотечение»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 08.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	977_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

Неточности в самом тексте КР

- У рекомендации о гемостатической терапии уровень доказательств записан как «уровень доказательств – 4» вместо принятого «уровень достоверности доказательств».

- В оглавлении PDF вместо номеров страниц нескольких разделов стоит «Ошибка! Закладка не определена».